



Taller 8

Más allá del prisma

Programa de Formación para Profesionales de la Salud Mental

Presentación del caso: El cuerpo sitiado y el silencio de la despedida

Alberto, de cincuenta y nueve años, arquitecto, fue derivado al equipo de cuidados paliativos y psico-oncología con un diagnóstico de cáncer de páncreas avanzado y metástasis hepáticas. El cuadro físico era de un deterioro acelerado: dolor abdominal refractario, caquexia severa, insomnio absoluto y una dependencia total de sus familiares para las actividades básicas de la vida diaria.





El motivo de la interconsulta

El motivo de la interconsulta solicitado por el equipo médico no era solo el manejo del dolor físico, sino un estado de **mutismo hostil y agitación paranoica**: Alberto rechazaba la medicación analgésica de rescate (opiáceos), se negaba a recibir la visita de sus hijos y respondía con agresividad verbal a los profesionales.

Su esposa se encontraba al borde del colapso emocional, atrapada entre la culpa y la impotencia.

Análisis desde la Clínica de la Convergencia

Un abordaje reduccionista biologicista habría interpretado el rechazo a los opiáceos como un "delirio confusional secundario a falla hepática" o "trastorno de adaptación con agitación", sugiriendo únicamente un aumento de neurolépticos sedantes. Un enfoque hermenéutico purista, por su parte, habría intentado interpretar el mutismo de Alberto como una "fijación melancólica" o un repliegue narcisístico sin atender al desborde neurobiológico de su organismo.

La **Clínica de la Convergencia** leyó el cuadro en su pluridimensionalidad:

El colapso alostático y el dolor total

Alberto no padecía meramente un dolor tisular; atravesaba un estado de "dolor total" donde la inflamación orgánica y la destrucción de su cuerpo se superponían con el terror insoportable a la pérdida de su autonomía y el pánico a la muerte próxima. Su sistema nervioso estaba inundado por una descarga masiva de cortisol y catecolaminas; la amígdala mantenía su cerebro en un estado de alerta y combate perpetuo, lo que explicaba su hostilidad defensiva.

La herida narcisística y la vergüenza de la dependencia

Para un hombre cuya identidad se había sostenido en la creación, el trabajo intelectual y el sostén de su familia, la degradación física y la necesidad de ser asistido para las funciones más íntimas representaban una humillación intolerable. Su silencio y su rechazo eran el último dique defensivo de un yo que prefería la rabia a la capitulación absoluta.

Herramienta 1: La Mesa de Trabajo Transdisciplinaria

ARTICULACIÓN FÁRMACO-PALIATIVA Y PSICOANÁLISIS

El analista estableció una coordinación inmediata con el equipo médico de cuidados paliativos. Se reajustó el esquema de analgesia y se administró un soporte farmacológico específico para modular el dolor somático y disminuir la agitación amigdalina.

El objetivo indispensable fue **bajar el ruido del sufrimiento tisular**. A las pocas horas, al disminuir la inundación de catecolaminas y permitir que Alberto descansara profundamente, su sistema nervioso recuperó una mínima ventana de tolerancia afectiva.

Reajuste de analgesia

Equipo médico coordina cambios farmacológicos

Recuperación de tolerancia afectiva

Restablecimiento nervioso

Sistema nervioso recupera ventana afectiva



Herramienta 2: La Presencia Continente y la Descompresión del Mando Narcisístico

En las entrevistas a la cabecera de la cama, el analista adoptó una postura de estricta disponibilidad sin exigencias interpretativas abstractas. Sabiendo que Alberto estaba atrapado en la vergüenza de su pérdida de autonomía, el analista validó explícitamente su sufrimiento sin compasión láudatoria, sino con rigor ético:

"No tenés que sostener a nadie ni demostrar fortaleza; es legítimo que estés enojado y devastado por lo que tu cuerpo está atravesando."

Esta intervención desarmó la coraza de hostilidad: **Alberto pudo llorar por primera vez desde el diagnóstico.**

Herramienta 3: La Palabra como Testamento Simbólico

ELABORACIÓN DEL DUELO ANTICIPADO Y DESPEDIDA



Una vez restaurada la tregua neurobiológica gracias a los analgésicos y a la escucha continente, se facilitó el reencuentro de Alberto con sus hijos y su esposa.

El analista operó como un **facilitador y testigo de la palabra última**. Se elaboró un espacio donde Alberto pudo:

- Legar sus deseos
- Ordenar los pendientes familiares
- Pedir perdón por sus rigideces
- Transformar el mutismo persecutorio en un **testamento vincular afectivo**



Desenlace clínico

Alberto falleció dos meses después de haber iniciado este abordaje convergente. Sus últimos días transcurrieron sin agitación paranoica, con el dolor físico controlado farmacológicamente y rodeado por el afecto consciente de su familia. Su esposa e hijos pudieron transitar el duelo posterior sin el peso de la culpa ni el rencor del aislamiento final.

El caso ejemplifica la potencia ética y clínica de la Clínica de la Convergencia en el umbral de la vida: cuando la medicina paliativa rescata al cuerpo del dolor biológico insoportable y el psicoanálisis ofrece un refugio a la palabra y al deseo, la muerte deja de ser un mero colapso mecánico para transformarse en el **último acto de humanización del sujeto.**